

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Протокол ургентного осмотра

Общетерапевтический осмотр пациента в критическом состоянии: обоснование последовательности, шкалы и трактовка находок

Критическое состояние и механизмы его развития, потенциально обратимые причины остановки кровообращения, задачи протокола, подготовка до прибытия, первичная оценка и вынужденные положения, последовательность ABCDE с пороговыми значениями и шкалами, повторный осмотр, мониторинг и маршрутизация. Распределение работы между лидером и адьютором приведено отдельным чек-листом.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 27 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Материал составлен по протоколу ургентного осмотра ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» (Трофимова И. А., 2025–2026). Ссылки на дозы и объём помощи приведены по приказу ДЗМ Москвы № 535 от 18.05.2023.

Предмет протокола

Общетерапевтический осмотр — комплекс мероприятий, выполняемых при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации соматическому пациенту в критическом состоянии, требующем срочного медицинского вмешательства.

Критическое состояние — крайняя степень любой, в том числе ятрогенной, патологии, для которой характерны тяжёлые расстройства жизненно важных функций, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной, требующие экстренной поддержки или искусственного замещения.

Из определения следует объём: осматриваются все системы, а не та, на которую указывает повод к вызову. Протокол задаёт последовательность, при которой жизнеугрожающие состояния выявляются и устраняются по ходу осмотра, а не после его завершения.

Задача протокола	Чем достигается
Своевременное выявление жизнеугрожающих состояний и их купирование	Фиксированная последовательность ABCDE, в которой каждое нарушение устраняется до перехода к следующему разделу
Раннее распознавание потенциально обратимых причин остановки кровообращения	Целенаправленный поиск состояний группы 4Г/4Т при осмотре
Полнота осмотра без потери времени	Параллельная работа двух членов бригады и объединение процедур, не мешающих друг другу
Сокращение времени от прибытия до доставки в стационар	Решение о маршруте принимается по результатам первичного осмотра, а не после полного обследования

Механизмы развития критического состояния

Протокол группирует причины по нарушенной функции. Группировка служит не классификацией ради полноты, а картой поиска: каждая группа проверяется на своём этапе осмотра.

Дыхательная недостаточность

Механизм	Причины
Центральная	Расстройство регуляции дыхания: отравление снотворными, передозировка наркотических средств, нарушение мозгового кровообращения

Механизм	Причины
Обструктивная	Отёк верхних дыхательных путей, бронхоспазм, обструкция инородным телом, слизью, жидкостью
Торакодиафрагмальная	Скопление жидкости и газа в плевральной полости, травмы грудной клетки, нарушение работы дыхательной мускулатуры, патология диафрагмы
Рестриктивная	Патология лёгочной ткани: пневмония, отёк лёгких, хронические заболевания лёгких
Вторичная	Анемия, нарушения кислотно-основного состояния, водно-электролитные нарушения

Нарушения гемодинамики

Тип шока	Ведущий механизм	Причины
Гиповолемический	Уменьшение объёма циркулирующей крови	Кровопотеря, ожоги, тяжёлый эксикоз, почечные потери, секвестрация в «третье пространство»
Дистрибутивный	Патологическое перераспределение при вазодилатации	Сепсис и перитонит, анафилаксия, воздействие токсических веществ
Кардиогенный	Снижение сократимости миокарда	Острая сердечная недостаточность, тахикардия, миокардит
Обструктивный	Механическое препятствие кровотоку	Тампонада сердца, напряжённый пневмоторакс

Гиповолемия разделяется на истинную, соответствующую гиповолемическому шоку, и относительную, соответствующую дистрибутивному шоку: в первом случае объём крови утрачен, во втором — перераспределён в расширенное сосудистое русло. Терминология «травматический шок» и «болевой шок» к употреблению не рекомендуется.

Прочие механизмы

Расстройства водно-электролитного баланса и кислотно-основного состояния, нейроэндокринные нарушения, изменения сознания: гипергликемия и гипогликемия, острая почечная и печёночная недостаточность, дегидратация и гипергидратация, острые нарушения мозгового кровообращения, воздействие токсических веществ, ацидоз и алкалоз.

Потенциально обратимые причины остановки кровообращения

Группы 4Г и 4Т проверяются в ходе осмотра, а не после развития остановки кровообращения: в этом и состоит смысл ургентного осмотра.

Группа	Состояние	Где выявляется при осмотре
Г	Гипоксия	А и В: проходимость дыхательных путей, эффективность дыхания, сатурация
Г	Гиповолемия	С: пульс, капиллярное наполнение, давление; Е: источник потерь
Г	Гипотермия	Е: термометрия; ЭКГ — волна Осборна

Группа	Состояние	Где выявляется при осмотре
Г	Гипо- и гиперкалиемия	Анамнез и ЭКГ; экспресс-исследование при технической возможности
Т	Тампонада сердца	В и С: вены шеи, глухие тоны, гипотензия; вынужденное положение сидя с наклоном вперёд
Т	Тромбоз коронарный и лёгочный	С: ЭКГ в 12 отведениях, анамнез
Т	Токсические причины	Анамнез, зрачки, запах, обстановка на месте вызова
Т	Напряжённый пневмоторакс	В: асимметрия трахеи, перкуссия, аускультация, вены шеи

Состояние	Градации
Гипотермия	Лёгкая 32–35 °С; умеренная 28–32 °С; тяжёлая ниже 28 °С
Гиперкалиемия	Лёгкая 5,1–5,9 ммоль/л; умеренная 6,0–6,4 ммоль/л; тяжёлая 6,5 ммоль/л и выше

Причины гиперкалиемии, значимые на догоспитальном этапе: острая почечная недостаточность и хроническая болезнь почек, острая надпочечниковая недостаточность, рабдомиолиз, передозировка калийсберегающими диуретиками, сахарный диабет.

Причины тампонады: травма сердца и перикарда, инфекции сердца, разрыв стенки на фоне инфаркта миокарда, операции на сердце, хроническая болезнь почек. Причины напряжённого пневмоторакса: травма грудной клетки, разрыв булл, спонтанный пневмоторакс, искусственная вентиляция лёгких, астматический статус.

Подготовка до прибытия

Работа начинается по пути следования и включает три составляющие.

Превентивный сбор анамнеза. Просматриваются данные ЕМИАС и личного кабинета ФОМС, данные опроса диспетчера при приёме вызова, наличие повторных вызовов к этому пациенту; при возможности выполняется звонок вызывающему для уточнения состояния.

Подготовка оборудования. Набор определяется поводом к вызову. Обязательно доставляются общепрофильная медицинская укладка, базовый ургентный набор и абонентский комплекс. При поводах, предполагающих остановку кровообращения — «без сознания», «нарушение сознания с угрозой жизни», «нарушение дыхания с угрозой жизни», «не дышит», «хрипит», «посинел», «подавился, не дышит» — дополнительно доставляются реанимационный набор соответствующего возраста, источник кислорода и дефибриллятор; при вызове «на себя» с реанимационным диагнозом — также аппарат искусственной вентиляции лёгких. В салоне заранее включается монитор, готовятся кислородная магистраль и раствор для инфузии, оборудование размещается так, чтобы выйти с ним без задержки.

Распределение ролей и инструктаж. Лидером является ответственный по бригаде либо наиболее опытный сотрудник; адьютор — помощник, выполняющий назначения лидера. Роли и порядок действий обсуждаются до прибытия.

Личная и инфекционная безопасность. Верхняя одежда застёгнута, карманы закрыты, волосы убраны, снято всё, что может помешать при манипуляциях. Перчатки и маски у всех членов бригады; защитные очки или экран обязательны при работе с дыхательными путями.

Первичная оценка

Оценка безопасности места вызова предшествует контакту с пациентом и включает агрессию окружающих, животных, нестабильные конструкции и труднодоступное расположение пациента, угрозу от движущегося транспорта, разливые жидкости и лёд. При непосредственной угрозе здоровью персонала место вызова покидается с докладом диспетчеру оперативного отдела.

Далее оценивается то, что видно до прикосновения: уровень сознания, положение пациента, доступность осмотра, наличие повреждений, общий вид, целенаправленные движения, цвет кожи, приблизительный возраст, пол, рост и вес. Первый вопрос окружающим — «что случилось».

Вынужденные положения как диагностический признак

Положение разделяется на активное, пассивное и вынужденное. Вынужденное положение пациент принимает для облегчения боли или одышки, и оно указывает направление поиска.

Положение	Состояние	Механизм облегчения
Ортопноэ: приподнятое изголовье, спущенные ноги	Сердечная недостаточность	Диафрагма смещается вниз, часть крови депонируется в венах нижних конечностей, уменьшается объём циркулирующей крови и работа сердца
Сидя с наклоном вперёд, часто на подушку	Скопление жидкости в полости перикарда	Жидкость смещается к основанию сердца; при сухом перикардите уменьшается трение листков
Сидя, опираясь руками на край кровати	Бронхиальная астма	Включается вспомогательная дыхательная мускулатура
Стоя без движения	Приступ стенокардии	Уменьшение загрудинной боли
На больном боку	Крупозная пневмония, сухой плеврит, туберкулёз	Ограничение движения плевральных листков уменьшает боль и улучшает вентиляцию здорового лёгкого
На больном боку	Абсцесс лёгкого, бронхоэктазы	Мокрота задерживается в полости, уменьшается кашель
На здоровом боку	Перелом ребёр	Уменьшается смещение отломков и раздражение межреберных нервов
На правом боку	Кардиомегалия	Поворот на левый бок усиливает чувство сдавления, одышку и сердцебиение
Лёжа на спине с приведёнными к животу ногами	Острый аппендицит, острый холецистит, язвенная болезнь	Облегчение боли
Лёжа на животе; коленно-локтевое положение	Опухоль поджелудочной железы, желудка; язва задней стенки желудка	Уменьшается давление на солнечное сплетение

Положение	Состояние	Механизм облегчения
«Легавой собаки»: на боку, голова запрокинута, ноги приведены к животу	Менингит, столбняк	Следствие ригидности мышц шеи и спины
«Причудливое», беспокойное, с постоянной сменой позы	Почечная и печёночная колика	Связано с остротой боли и продвижением камня

Оценка сознания

Уровень сознания оценивается по шкале AVPU: А — в сознании, активен; V — реагирует на голос (оглушение, сопор); Р — реагирует на боль (сопор, неглубокая кома); U — не реагирует (глубокая кома).

Сочетание отсутствия сознания с отсутствием дыхания требует немедленного начала сердечно-лёгочной реанимации. Сочетание отсутствия сознания с сохранённым дыханием переводит бригаду к осмотру по ABCDE.

А. Дыхательные пути

При ясном сознании и сохранённой речи проходимость дыхательных путей подтверждена самим фактом речи, и отдельная оценка не требуется. При сниженном сознании оценка проходимости и оценка эффективности дыхания выполняются одновременно.

Приём: ладонь одной руки на лбу, указательный и средний пальцы другой — на подбородке; голова запрокидывается, нижняя челюсть подтягивается вверх, рот приоткрывается. Ухо приближается ко рту пациента для выявления посторонних звуков.

Находка	Механизм	Первоочередное действие
Храп	Западение корня языка при сниженном тонусе	Выдвижение нижней челюсти, воздуховод
Булькающее дыхание	Жидкое содержимое в дыхательных путях	Санация верхних дыхательных путей
Стридор	Сужение на уровне гортани: отёк, инородное тело, ожог	Решение о протекции дыхательных путей; при неэффективности мер — коникотомия как резерв
Апноэ при отсутствии сознания	Остановка дыхания	Сердечно-лёгочная реанимация

Методы протекции применяются последовательно, каждый следующий — только при неэффективности предыдущего: воздуховод, надгортанное устройство или интубация трахеи, коникотомия. После каждого вмешательства проходимость оценивается заново.

В. Дыхание

Эффективность дыхания

Оценка занимает 10 секунд при открытых дыхательных путях и строится по правилу «вижу — слышу — ощущаю»: экскурсия грудной клетки, звуки изо рта пациента,

движение воздуха. Оцениваются наличие дыхания, частота, глубина и усилие. Число вдохов за 10 секунд умножается на 6.

Дыхание считается эффективным при частоте 8–32 в минуту. Частота менее 8 или более 32 в минуту требует активной респираторной поддержки немедленно: при I–II степени недостаточности — оксигенотерапия, при III–IV степени — вентиляция дыхательным мешком, подключённым к источнику кислорода.

Степени острой дыхательной недостаточности

Приведены по В. Л. Кассилю (2004).

Степень	Сознание	ЧДД	Кожа	ЧСС	Артериальное давление	SpO ₂ на фоне оксигенотерапии
Норма	Ясное	12–16	Обычной окраски	Норма	Норма	96–99 %
I	Ясное	14–20	Бледность, умеренный цианоз	100–110	Норма или умеренная гипертензия	92–95 %
II	Возбуждение или агрессия	20–30	Цианоз	110–120	Умеренная гипертензия	90–92 %
III	Спутанность, оглушение	30–40	Выраженный цианоз	120–140	Гипертензия	85–90 %
IV	Гипоксическая кома, судороги, мидриаз	Более 40 или менее 8	«Мраморный» цианоз	Более 140 или менее 60, возможна аритмия	Гипотензия	Менее 85 %

Шея

Признак	Что означает
Смещение трахеи	Неравномерное давление в грудной клетке: травматический пневмоторакс как наиболее частая причина, ателектаз, плевральный выпот, фиброторакс, опухоли бронхов, лёгких и плевры, лимфомы средостения, состояние после пневмонэктомии
Набухание вен шеи	Правожелудочковая недостаточность, тампонада, констриктивный перикардит, эмфизема, пневмоторакс, сдавление или тромбоз верхней полой вены. Симптом Кулсмауля — набухание вен на вдохе; воротник Стокса — резкое расширение вен с отёком при сдавлении верхней полой вены
Западение вен шеи	Снижение объёма циркулирующей крови, шок

Грудная клетка

Осматриваются симметричность, участие в акте дыхания, наличие повреждений и деформаций, втяжение или выбухание межрёберных промежутков. Аускультация и перкуссия выполняются обязательно, на симметричных участках, не менее чем в шести точках: второе-третье межреберье по средней ключичной линии, пятое-шестое по передней подмышечной, шестое-седьмое по задней подмышечной.

Пульсоксиметрия выполняется с началом осмотра грудной клетки — время, необходимое прибору на измерение, совмещается с осмотром.

С. Кровообращение

Пульс

Первым действием одновременно оцениваются пульс на магистральной (сонной) и периферической (лучевой) артерии с одной стороны в течение 10 секунд. Оцениваются наличие, частота, наполнение и ритмичность.

Находка	Ориентировочное систолическое давление
Пульс определяется на лучевой артерии	Более 80 мм рт. ст.
Пульс определяется только на сонной артерии	Более 40 мм рт. ст.

Сравнительная оценка пульса проводится одновременно на обеих лучевых артериях в течение 10 секунд. Асимметричный пульс (*pulsus differens*) возникает при компрессии или обтурации артериальных стволов, предшествующих лучевой артерии: плечевой, подмышечной, подключичной артерии, плечеголового ствола, аорты. Внешняя компрессия возможна при увеличении подмышечных лимфатических узлов, келоидном рубце, опухолях средостения, синдроме передней лестничной мышцы, шейном ребре, митральном стенозе. Сужение просвета — при синдроме Такаясу, атеросклерозе плечеголового ствола и подключичной артерии, артериальном тромбозе, аномалиях развития сосудов.

Характеристика пульса	Обозначение	Состояния
Большой, обычно с повышенным напряжением	p. magnus, p. durus	Гипертиреоз, анемия, лихорадка, недостаточность аортального клапана, открытый артериальный проток
Малый	p. parvus	Хроническая артериальная гипотензия, воздействие холода, хроническая сердечная недостаточность
Нитевидный	p. filiformis	Коллапс, шок, пароксизмальная тахикардия
Парадоксальный, резко ослабевающий на вдохе	p. paradoxus	Экссудативный или слипчивый перикардит, большой плевральный выпот, обширные уплотнения лёгких
Альтернирующий	p. alternans	Тяжёлое поражение миокарда
Дефицит пульса	p. deficiens	Фибрилляция предсердий, частая экстрасистолия: число сердечных сокращений превышает частоту пульса на периферии

Капиллярное наполнение

Симптом белого пятна определяется надавливанием подушечками больших пальцев на тенар кисти в течение 5 секунд. Время восстановления естественной окраски до 3 секунд соответствует норме, свыше — циркуляторным нарушениям. Признак используется и для оценки динамики состояния на этапах помощи.

Тоны сердца, давление, ЭКГ и анамнез

Аускультация на этом этапе выполняется в одной точке с одновременной оценкой пульса на лучевой артерии за 10 секунд; полная аускультация в пяти точках относится к повторному осмотру. Артериальное давление измеряется только после сравнительной оценки пульса, поскольку раздувание манжеты искажает её результат; при выявленной асимметрии — на обеих руках.

Регистрация ЭКГ в 12 отведениях, обеспечение сосудистого доступа и сбор анамнеза совмещаются во времени: пока регистрируется ЭКГ, собирается анамнез, а сосудистый доступ обеспечивается параллельно. При признаках нарушения гемодинамики инфузия кристаллоидами начинается сразу после обеспечения доступа.

Вопросы анамнеза: что произошло и когда; что предшествовало ухудшению; какие лекарства принимал и что принимает регулярно; хронические заболевания; аллергологический анамнез; эпидемиологический и гинекологический анамнез.

D. Неврологический статус

Шкала комы Глазго

Оценивается лучший ответ, полученный за весь осмотр. Открывание глаз и речевая реакция фиксируются ещё при оценке сознания, двигательная — при осмотре и обеспечении венозного доступа.

Открывание глаз	Балл
Произвольное, стимула не требуется	4
На речевую команду, на обычный или громкий голос	3
На болевое раздражение — надавливание на кончик ногтя	2
Отсутствует	1

Речевая реакция	Балл
Ориентирован и контактен: называет имя, ориентирован в пространстве и времени	5
Спутанная речь: дезориентирован, но свободно общается	4
Отдельные понятные слова	3

Речевая реакция	Балл
Нечленораздельные звуки, стон	2
Отсутствует	1

Двигательная реакция	Балл
Выполняет команды	6
Локализует боль: поднимает руки при надавливании на трапецевидную мышцу	5
Отдёргивает конечность на боль	4
Патологическое сгибание, декортикационная ригидность	3
Разгибание, децеребрационная ригидность	2
Ответа нет	1

Сумма	Уровень сознания	Содержание
15	Ясное сознание	—
13–14	Умеренное оглушение	Сонливость, нарушение внимания, утрата связности мыслей и действий
9–12	Сопор	Угнетение сознания с сохранением координированных защитных реакций и открывания глаз на сильные раздражители
7–8	Кома I	Разбудить невозможно, на боль реагирует простейшими беспорядочными движениями, не локализует её
5–6	Кома II	Двигательных реакций на боль нет
3–4	Кома III	Реакции отсутствуют полностью; атония, арефлексия, возможны нарушение дыхания и угнетение сердечной деятельности

Зрачки

В норме зрачки круглые и равные, диаметр при комнатном освещении 2–6 мм; анизокория до 1 мм считается вариантом нормы. Реакция на свет бывает прямой — при освещении исследуемого глаза, и содружественной — в парном неосвещённом глазу; содружественная реакция объясняется частичным перекрестом волокон зрачкового рефлекса в области хиазмы.

Картина	Трактовка
Точечные зрачки	Повреждение моста

Картина	Трактовка
Зрачки среднего размера, не реагирующие на свет	Поражение среднего мозга
Узкие с замедленной реакцией	Большинство интоксикаций лекарственными препаратами
Широкие, на свет не реагируют	Отравление препаратами, содержащими атропин
Одностороннее расширение с отсутствием реакции	Дислокационный синдром при височно-тенториальном вклинении; аневризма задней соединительной артерии; у пациента в сознании чаще доброкачественный характер
Реакция на свет отсутствует с двух сторон	Отравление барбитуратами, производными фенотиазина, метанолом, аминогликозидами; гипотермия; клиническая смерть

Сохранность реакции зрачков на свет — простейший и наиболее важный объективный признак, отличающий метаболическую кому от деструктивной: реакция устойчива к метаболическим поражениям, а при повреждении ствола мозга нарушается всегда.

При отсутствии спонтанных движений глазных яблок исследуется окулоцефалический рефлекс (проба «кукольных глаз»), и только при отсутствии признаков повреждения шейного отдела позвоночника. Проба положительна, если при повороте головы глаза продолжают смотреть прямо, то есть движутся в противоположную повороту сторону: рефлексорная дуга сохранена, повреждения ствола нет. Проба отрицательна, если глазные яблоки остаются по средней линии и движутся вместе с головой: это указывает на поражение ствола.

Менингеальные симптомы

Симптом	Приём	Положительный результат
Ригидность затылочных мышц	Рука под затылок, сгибание головы с приближением подбородка к груди	Подбородок не приводится к груди; оценивается напряжение задних шейных мышц и расстояние в пальцах
Брудзинского верхний	Тот же приём	Непроизвольное сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах с подтягиванием к животу
Кернига	Нога сгибается под углом 90° в тазобедренном и коленном суставах, затем разгибается в коленном	Разгибание невозможно или ограничено из-за напряжения мышц
Брудзинского средний	Надавливание ребром или основанием ладони на лонное сочленение	Непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах с приведением к туловищу
Брудзинского нижний	Разгибание одной ноги, согнутой в тазобедренном и коленном суставах	Непроизвольное сгибание противоположной ноги

Ригидность затылочных мышц оценивается сразу после зрачков, симптомы Кернига и Брудзинского — вместе с оценкой мышечного тонуса.

Мышечный тонус и сила

Тонус оценивается последовательно на каждой конечности; для сокращения времени допускается попарная оценка верхних и нижних конечностей. Приёмы: пассивное сгибание и разгибание в локтевом суставе, пронация и супинация предплечья; в положении лёжа — быстрый подъём бедра за колено, пассивные движения стопы.

Изменение	Картина	Состояния
Гипотония	Пассивные движения без сопротивления, объём увеличен	—
Атония	Резко выраженное снижение тонуса	Периферический парез, патология мозжечка или экстрапирамидной системы
Гипертония, спастичность	Выраженное сопротивление в начале движения, затем ослабление — феномен складного ножа — и нарастание к концу	Центральный паралич

Мышечная сила оценивается при уровне сознания, достаточном для выполнения команд, по шестибальной шкале.

Балл	Содержание
5	Сила полная
4	Пациент сопротивляется, но уступает в силе — лёгкий парез
3	Активные движения есть, сопротивления нет — умеренный парез
2	Движения возможны на опоре, без преодоления силы тяжести конечности — глубокий парез
1	Движения по типу шевеления
0	Движений нет — паралич

Глюкометрия обязательна при нарушении сознания и выполняется параллельно неврологической части осмотра.

Е. Общий осмотр

Термометрия начинается в начале этапа, поскольку требует времени; при подозрении на гипотермию температура измеряется ректально или в паховой складке.

Область	Что оценивается
Кожа и слизистые	Цвет, влажность, сыпь и патологические элементы, пролежни, рубцы, повреждения — на участках, не осмотренных ранее
Живот	Симметричность, участие в акте дыхания, повреждения; пальпация в четырёх точках: боль, напряжение
Бедренные артерии	Сравнительная пальпация: симметричность, наполнение. Ослабление или отсутствие пульса только на бедренных артериях возможно при артериите, двустороннем атероматозе, тромбозе; асимметрия может указывать на расслоение аорты
Конечности	Состояние кожи, повреждения, отёки, варикозно расширенные вены
Спина	Осмотр в устойчивом боковом положении: кожа, повреждения, пролежни
Ректальное исследование	По показаниям: при признаках шока — снижении артериального давления, увеличении времени капиллярного наполнения, тахикардии — для исключения кишечного кровотечения

При выявлении болезненности или напряжения живота подробный осмотр переносится на повторный осмотр.

После первичного осмотра

Составляющая	Содержание
Повторный осмотр	Проводится при неоднозначной клинической картине и охватывает только те области и системы, где выявлены отклонения либо требуется уточнение
Мониторинг	ЭКГ-мониторинг, артериальное давление, сатурация, капнометрия. При критическом состоянии ЭКГ регистрируется на бумажном носителе каждые 5 минут
Терапия	По приказу № 535 в соответствии с выявленным состоянием. Начало возможно сразу после обеспечения венозного доступа при признаках нарушения гемодинамики
Дополнительные исследования	Ультразвуковое исследование, капнометрия, экспресс-тесты, анализ крови — при наличии показаний и технической возможности, в рамках повторного осмотра; при необходимости дистанционный консилиум
Маршрутизация	Медицинская эвакуация с непрерывным мониторингом и продолжением терапии в пути; при необходимости вызов бригады «на себя»

Источники

- Протокол ургентного осмотра: порядок проведения общетерапевтического осмотра пациента в критическом состоянии бригадами скорой медицинской помощи. ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы; Трофимова И. А. при участии Колесник А. В., Мец И. С., Вахромеева С. Г., 2025–2026 — определения, последовательность осмотра, пороги эффективности дыхания, ориентиры систолического давления по пульсу, время капиллярного наполнения, шкалы и трактовки находок.
- Кассиль В. Л. Механическая вентиляция лёгких в анестезиологии и интенсивной терапии, 2004 — степени острой дыхательной недостаточности.
- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 535 от 18.05.2023 «Об утверждении Алгоритмов оказания скорой и неотложной медицинской помощи» — объём терапии по выявленному состоянию.

Выходные данные

Материал: «Протокол ургентного осмотра». Версия 1.0. Распределение работы между лидером и адьютором вынесено в отдельный чек-лист «Ургентный осмотр: лидер и адьютор».

Серия: «Крещение поворотом» — материалы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Оговорка. Материал носит учебный характер, не является нормативным документом и не заменяет действующие приказы, клинические рекомендации и распоряжения службы. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.